

УДК: 616-006.6

Н.С. Нурғалиев

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Мультидисциплинарный подход в диагностике и лечении рака предстательной железы

Аннотация. 16 мая в г. Алматы прошла республиканская семинар-конференция «Мультидисциплинарный подход в диагностике и лечении рака предстательной железы», организованная центром онкоурологии КазНИИОиР. Основной идеей семинара было объединение усилий врачей всех специальностей в выработке единых подходов лечения, согласно периодическим протоколам диагностики и лечения рака предстательной железы – организации мультидисциплинарного подхода как эталона качества в принятии правильного решения. Проведение таких семинар-конференций поможет практическим врачам – онкоурологам, химиотерапевтам и радиологам овладеть навыками ведения и лечения больных с РПЖ на различных стадиях заболевания. Семинар прошел согласно плана, с интерактивным голосованием, с привлечением аудитории в дискуссии.

Ключевые слова: рак предстательной железы, мультидисциплинарный подход

16 мая в г. Алматы прошла республиканская семинар-конференция «Мультидисциплинарный подход в диагностике и лечении рака предстательной железы». Данный семинар был организован центром онкоурологии КазНИИОиР при поддержке компаний «Байер», «Янсен» и «Толмар». На семинар были приглашены спикеры из России – ведущий научный сотрудник отделения урологии института им. П.А. Герцена (г. Москва), к.м.н. К.М. Ньюшко, с докладом «Кастратрезистентный РПЖ. Время наступления, особенности диагностики и лечения»; из Израиля – руководитель онкоурологической службы Института онкологии Медицинского Центра Меир (г. Кфар-Сава) доктор Кейзман Д. с докладом «Современные подходы в лечении костных метастазов при кастратрезистентном РПЖ». Были затронуты темы диагностики РПЖ, проблемы скрининга, стадирования, подходов в лечении на разных стадиях заболевания с разбором клинических случаев. В качестве спикеров выступали ведущие сотрудники КазНИИОиР, занимающиеся проблемами РПЖ – онкоурологи, химиотерапевты, радиологи; ведущие сотрудники из других регионов – онкодиспансеров Караганды, Шымкента, Алматы.

В семинар-конференции приняли участие специалисты из разных регионов республики – 30 урологов и онкоурологов ООД, 23 химиотерапевта, 15 радиологов, 4 специалиста СКДО, 4 хирурга; всего – 80 человек, принимающие непосредственное участие в диагностике и лечении рака предстательной железы (список зарегистрированных прилагается). Основной идеей семинара было объединение усилий врачей всех специальностей в выработке единых подходов лечения, согласно периодическим протоколам диагностики и лечения рака предстательной железы – организации мультидисциплинарного подхода как эталона качества в принятии правильного решения. Семинар прошел согласно плана, с интерактивным голосованием, с привлечением аудитории в дискуссии.

После официального открытия конференции первый доклад был посвящен проводимому в республике скринингу рака предстательной железы. На сегодняшний день рак простаты внедрен в нескольких регионах нашей страны, есть свои положительные моменты и недостатки, о которых рассказала руководитель республиканского скринингового отдела (СКДО) Жылкайдарова А.Ж. Так как метод скрининга состоит из нескольких этапов, проблемы возникают на каждом уровне – начиная от приглашения участников целевой группы на скрининг и сдачи анализа на простато-специфический антиген (ПСА) и до получения гистологического заключения рака. Докладчиком было акцентировано внимание на основных проблемах, пробелах на том или ином уровне и что необходимо делать, чтобы избежать данные недостатки.

Для успешного лечения в онкологии одним из основных требований является установление правильной стадии заболевания. Об этом рассказал врач отделения онкоурологии КазНИИОиР Онгарбаев Б.Т. Для привлечения аудитории к дискуссии обсуждались несколько задач и с помощью интерактивного голосования была осуществлена обратная связь со слушателями.

Следующий доклад был сделан руководителем центра онкоурологии Нурғалиевым Н.С. «Мультидисциплинарный подход в лечении РПЖ». Мультидисциплинарный подход в лечении рака простаты в развитых странах мира стали внедрять с 1994 года, и уже в начале этого столетия многие страны приняли этот подход за основу. К примеру, в США МДГ является обязательным для аккредитации медицинских центров, предоставляющих лечение рака; во Франции и Бельгии МДГ внедрено регламентирующим законом с 2003 года; в Испании МДГ является приоритетом в системе здравоохранения с 2006 года; а в Германии созданы сертифицированные центры рака простаты с 2008 года. В нашей стране положение о мультидисциплинарной группе онкологической организации разработано и регламентировано приказом МЗ РК № 540 от 12.08.2011г «Об утверждении Положения о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих онкологическую помощь населению Республики Казахстан» и приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 02.08.2013г. №452 «Об утверждении Стандарта организации оказания онкологической помощи населению Республики Казахстан». Докладчиком на конкретных примерах зарубежных стран показано преимущество в проведении заседаний МДГ для постановки диагноза и выбора тактики лечения на каждого пациента индивидуально. Многие исследователи показывают, что МДГ улучшает выживаемость в лечении рака, так как путем предоставления командного подхода пациентам назначается правильное лечение в нужное время. Немаловажным моментом является информированность пациента о предлагаемых альтернативных методах лечения, так как пациенту объясняются преимущества и возможные побочные эффекты от каждого метода и он

должен принимать решение в выборе тактики лечения, т.е. должна быть обоюдная ответственность.

Далее выступил заместитель главного врача по хирургии Карагандинского областного онкологического диспансера Кожамбердин К.Е. с докладом «Радикальная простатэктомия. Показания. Опыт применения». Им подробно доложены показания для проведения оперативного лечения рака простаты, согласно международным рекомендациям; ожидаемые побочные эффекты, преимущества и недостатки при применении в локализованной и местно-распространенной стадии. Показан опыт использования радикальной простатэктомии с 2010 года.

Одним из альтернативных методов локализованного и местно-распространенного рака простаты является лучевая терапия. О методах лучевой терапии, показаниях и противопоказаниях был сделан доклад д.м.н. Ким В.Б., долгое время занимавшегося данной проблемой в КазНИИОиР. Лучевая терапия в зависимости от способа подведения ионизирующего излучения к патологическому очагу подразделяется на контактную и дистанционную. При этом 95% используется дистанционная лучевая терапия. Если ранее использовалось 2D конвенциональное облучение из 2-х полей, то в последующем с модернизацией аппаратов лучевой терапии появилось 3Dконформная радиотерапия, лучевая терапия с модуляцией интенсивности (IMRT), лучевая терапия, управляемая по изображениям (IGRT), которые внедрены и используются в КазНИИОиР. Данные методики позволяют повысить дозу ионизирующего излучения подводимой к опухоли (до 78-80Гр), снизить дозу облучения в здоровых тканях, увеличить выживаемость и локальный контроль, уменьшить частоту и тяжесть осложнений, соответственно повысить качество жизни пациентов, получающих лучевую терапию. В связи с внедрением скрининга рака простаты и выявления все большего количества больных на ранних стадиях, возросла актуальность внедрения контактной лучевой терапии - брахитерапии простаты, над которой сейчас вплотную занимается руководство института онкологии и в ближайшем будущем должно быть внедрено в практику.

После проведения радикальной простатэктомии, особенно у пациентов с высоким риском прогрессирования, у больных с местно-распространенным раком простаты, есть вероятность развития локального рецидива или мтс в лимфоузлы малого таза. Как быть в подобной ситуации клиницисту? Об этом был сделан доклад врачом-радиологом центра онкоурологии КазНИИОиР Ишкининым Е.И. Так, по данным ряда авторов в 56% случаях, после РПЭ требуется проведение адъювантной (немедленной) или спасительной (отсроченной) ЛТ. Согласно рекомендациям Американской ассоциации урологов (AAU) послеоперационная адъювантная радиотерапия должна быть стандартом для мужчин с раком простаты категории Т3, перенесших радикальную простатэктомию, вне зависимости от того, повышается ли уровень ПСА или нет. При этом в пользу выбора адъювантной лучевой терапии должны быть: позитивные хирургические края, экстракапсулярное распространение, вовлечение семенных пузырьков. Адъювантная лучевая терапия (АЛТ) должна быть отсрочена до тех пор, пока не восстановится удержание мочи. Но есть и противники данного

метода, т.к. токсичность от проводимой адъювантной лучевой терапии может превосходить преимущество, а также у части пациентов может быть системное прогрессирование, где местная терапия (АЛТ) не будет эффективна. Спасительная лучевая терапия (СЛТ) проводится в случаях, когда четко имеется биохимический рецидив (повышение ПСА более 0,5 нг/мл от «надира») без очевидных клинических признаков прогрессирования (но при этом повышение ПСА необходимо дифференцировать от системного прогрессирования). СЛТ показана, если ожидаемая продолжительность жизни будет превышать 10 лет, и проводить ее желательно методом IMRT.

После завершения разбора локальных видов лечений было разобрано несколько задач, где слушатели могли поучаствовать в дискуссии. Следующий этап – системная терапия. Учитывая, что рак простаты гормонально зависимая опухоль, одним из основных методов лечения распространенного процесса является гормонотерапия, на чем остановился в своем докладе руководитель центра онкоурологии Нургалиев Н.С. Доклад был построен в виде вопросов, часто задаваемых практическими врачами -онкоурологами и химиотерапевтами, и ответов на них. Несмотря на проводимую гормонотерапию, рано или поздно развивается кастрат-резистентность (КРРПЖ), что требует добавления 2-й линии гормонотерапии (абиратерон) или химиотерапии. О том как определить кастратрезистентность и какие варианты терапии мы должны предложить врачам, поделился в своем докладе к.м.н. Ньюшко К.М. КРРПЖ говорит о том, что болезнь прогрессирует, и зачастую средняя выживаемость пациентов с симптомами заболевания составляет от 6-9 месяцев до 14-16 месяцев, а у бессимптомных пациентов от 9-12 месяцев до 20-36 месяцев, в зависимости от обширности метастатических очагов. При данном состоянии стандартов уже не существует, и если ранее в арсенале был только один химиотерапевтический препарат – доцетаксел, то сегодня появились другие препараты, которые способны продлить жизнь пациентов, улучшить качество жизни. Одним из подобных препаратов, применяемых при КРРПЖ, является Абиратерон, который сегодня используют в виде 2-й линии гормонотерапии. Об этом препарате, показаниях к назначению и опыту применения поделились заведующий отделением дневного стационара химиотерапии КазНИИОиР Абдрахманов Р.З. и врач-онкоуролог Алматинского городского онкоцентра Барсов С.В. Препарат изначально был показан при прогрессировании после химиотерапии Таксотером, но на сегодняшний день есть обоснованные показания для назначения его до химиотерапии. Конечно, необходимо производить тщательный отбор пациентов, есть предпочтения в выборе тактики до- и после химиотерапии, основываясь на опыте зарубежных коллег.

Одним из основных мишеней метастазирования рака предстательной железы являются кости скелета. Так по данным разных авторов, до 70-90% первые метастазы поражают именно костную ткань, наиболее часто начинаясь с поражения костей таза, поясничного отдела позвоночника, и далее любые другие кости скелета. Основным симптомом в данной ситуации являются боли, порой выраженной интенсивности, лишаящие покоя больных, а иногда и приводящие к переломам, к

компрессии спинного мозга и вытекающими от этого последствиями. В данной ситуации назначаются бисфосфонаты, лучевая терапия на очаг поражения с целью снятия болевого синдрома. Относительно недавно стал применяться препарат Деносумаб (ингибитор RANKL – подавляя образования остеокластов, способствуют уменьшению резорбции костной ткани) и радионуклидная терапия (радий-223, самарий-153, стронций-89). О лечении метастатических поражений костей и использовании самария-153 в своей клинической практики поделился заведующий химиотерапии и эндоваскулярной онкологии ООД ЮКО, г. Шымкент Арыбжанов Д.Т. Одним из последних достижений в лечении метастатических осложнений является Альфарадин: радиофармпрепарат на основе изотопа радия-223, способный к селективному накоплению в костных очагах, являющийся источником α -излучения. В мире не так много клиник, имеющих большой опыт в использовании данного препарата. Своим опытом в использовании Альфарадина (торговое название «Ксафиг»), международных клинических исследований, использованием Деносумаба, и вообще опытом лечения больных КРРПЖ поделился доктор Кейзман Д. Для аудитории было приятно услышать о данных препаратах и их эффективности, так как есть надежда

на то, что в ближайшем будущем наши пациенты будут иметь возможность получения данного вида терапии.

Организаторами были разработаны анкеты и розданы участникам в начале конференции. В опросе приняло участие 44 респондента, основная масса которых (95%) осталась довольной программой и организацией семинар-конференции, с пожеланием проведения подобных мероприятий на постоянной основе 1-2 раза в год. Проведение таких семинар-конференций поможет практическим врачам – онкоурологам, химиотерапевтам и радиологам овладеть навыками ведения и лечения больных с РПЖ на различных стадиях заболевания.

Кооперация всех специалистов, участвующих в лечении больных РПЖ – мультидисциплинарные группы должны проводиться во всех диспансерах на постоянной основе. Мы надеемся, что на местах, в региональных онкодиспансерах, врачи «правильно» ведут больных состоящих на учете с раком предстательной железы, проводят постоянный мониторинг для определения времени прогрессирования со своевременным выявлением больных КРРПЖ, так как вовремя начатая терапия – залог более долгосрочного выживания пациентов с лучшим качеством жизни.

Тұжырым
Н.С. Нұрғалиев

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Қуық асты безі обырын емдеуіне көпсалалы көзқарас

16 мамырда Алматыда Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты онкоурология орталығының ұйымдастыруымен «Қуық асты безі обырын емдеуіне көпсалалы көзқарас» атты республикалық семинар-конференция өтті. Конференцияға еліміздің барлық онкология диспансерлерінен 80 маман онкологтар - онкоурологтар мен урологтар, химиотерапевт және радиолог мамандары қатысты. Семинардың негізгі мақсаты – аталған барлық мамандардың білімі мен күшін қуық асты без обырын емдеуіне жұмылдыру, бұл дертті анықтау мен емдеу кезінде дүние жүзілік емдеудің үлгілері нәтижесінде даярланған протоколдарды негіз ретінде қолданып, аталған барлық мамандарды жеке әр науқастың диагностика мен емдеуіне тиісті шешім қабылдау. Бұндай семинарлардың өткізілуі мамандарға ғылымның соңғы жетістіктерін қолданып, қуық асты без обырын дер кезінде анықтау мен дұрыс емдеуге көмегін тигізеді. Конференция тыңдаушыларды интерактивті дауыс беру мен дискуссияға қатыстырып, жоспар бойынша өткізілді.

Түйінді сөздер: асты безі обырын, көпсалалы көзқарас.

Summary
N.S.Nurgaliyev

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

“The multidisciplinary approach to diagnosis and treatment of prostate cancer”

On the 16th of May in Almaty was held Republic seminar-conference “Multidisciplinary approach in the diagnosis and treatment of prostate cancer”, organized by the center oncurology KazSRI O&R. The main idea of the seminar was to join efforts of physicians of all specialties in the development of common approaches to the treatment, according to the periodic protocols of diagnosis and treatment of prostate cancer - the organization of a multidisciplinary approach as a benchmark of quality in making correct decisions. Carrying out of such a seminar-conference will help to practitioners - oncurology, chemotherapist radiation oncologist to acquire skills of management and treatment of patients with prostate cancer at different stages of the disease. The seminar was held according to plan, with the interactive voting, with the involvement of the audience in discussion.

Key words: prostate cancer, multidisciplinary approach.